認定結果(テスト用設定)

テスト用架空事例

要介護度	要介護3
認定日	令和8年7月15日(テスト用)
認定の有効期間	令和8年6月10日～令和9年6月30日(区分変更・12か月)(テスト用)

認 定 調 査 票 (概 況 調 査)

Ⅰ 調査実施者(記入者)

実施日時	令和8年6月24日 (テスト用)
実施場所	自宅
記入者氏名・所属	＊＊＊＊(テスト用)

Ⅱ 調査対象者

過去の認定	区分変更申請(前回:要介護2)		
対象者氏名	西川 正弘 (にしかわ まさひろ)	性別	男
生年月日	昭和26年(1951年)11月3日	年齢	74歳
現住所	○○県○○市＊＊＊＊(テスト用)		
家族等連絡先	＊＊＊＊(テスト用)		

Ⅲ 現在受けているサービスの状況

介護給付 訪問リハビリテーション(週2回)、通所介護(週2回)、訪問看護(週1回・服薬と症状の確認)、福祉用具貸与(特殊寝台・特殊寝台付属品・歩行器・手すり)。

Ⅳ 置かれている環境等(調査対象者の家族状況、調査対象者の居住環境、日常的に使用する機器・器械の有無等)

家族状況	妻(72歳)と二人暮らし。主な介護者は妻。長女(45歳)は市内に住み、週1回訪問。
居住環境	平屋の持ち家。廊下・トイレ・浴室に手すりあり。
使用している機器等	歩行器、特殊寝台、手すり、服薬時間を知らせるアラーム付き時計。
生活歴	高校の数学の教員として定年まで勤めた。囲碁と散歩が趣味だった。
本人・家族の主訴	本人:「薬が切れると体が固まって動けなくなるのがつらい。」 妻:「動ける時間と動けない時間の差が大きく、夜中のトイレの介助で眠れない。」

認定調査票(基本調査)

テスト用架空事例

該当する選択肢を〇で囲んでいます。

第1群 身体機能・起居動作	
1-1 麻痺等の有無 (複数選択可)	(ない) 左上肢　右上肢　左下肢　右下肢　その他(四肢の欠損)
1-2 拘縮の有無 (複数選択可)	(ない) 肩関節　股関節　膝関節　その他(四肢の欠損)
1-3 寝返り	つかまらないでできる (何かにつかまればできる) できない
1-4 起き上がり	つかまらないでできる (何かにつかまればできる) できない
1-5 座位保持	できる (自分の手で支えればできる) 支えてもらえればできる　できない
1-6 両足での立位保持	支えなしでできる (何か支えがあればできる) できない
1-7 歩行	つかまらないでできる (何かにつかまればできる) できない
1-8 立ち上がり	つかまらないでできる (何かにつかまればできる) できない
1-9 片足での立位	支えなしでできる　何か支えがあればできる (できない)
1-10 洗身	介助されていない (一部介助) 全介助　行っていない
1-11 つめ切り	介助されていない　一部介助 (全介助)
1-12 視力	(普通(日常生活に支障がない)) 約1m離れた視力確認表の図が見える 目の前に置いた視力確認表の図が見える　ほとんど見えない 見えているのか判断不能
1-13 聴力	(普通) 普通の声がやっと聞き取れる　かなり大きな声なら何とか聞き取れる ほとんど聞えない　聞えているのか判断不能
第2群 生活機能	
2-1 移乗	介助されていない (見守り等) 一部介助　全介助
2-2 移動	介助されていない　見守り等 (一部介助) 全介助
2-3 えん下	できる (見守り等) できない
2-4 食事摂取	介助されていない (見守り等) 一部介助　全介助
2-5 排尿	介助されていない　見守り等 (一部介助) 全介助
2-6 排便	介助されていない　見守り等 (一部介助) 全介助
2-7 口腔清潔	介助されていない (一部介助) 全介助
2-8 洗顔	(介助されていない) 一部介助　全介助
2-9 整髪	(介助されていない) 一部介助　全介助
2-10 上衣の着脱	介助されていない　見守り等 (一部介助) 全介助
2-11 ズボン等の着脱	介助されていない　見守り等 (一部介助) 全介助
2-12 外出頻度	(週1回以上) 月1回以上　月1回未満
第3群 認知機能	
3-1 意思の伝達	(調査対象者が意思を他者に伝達できる) ときどき伝達できる ほとんど伝達できない　できない
3-2 毎日の日課を理解	(できる) できない
3-3 生年月日や年齢を言う	(できる) できない
3-4 短期記憶	(できる) できない
3-5 自分の名前を言う	(できる) できない
3-6 今の季節を理解する	(できる) できない
3-7 場所の理解	(できる) できない
3-8 徘徊	(ない) ときどきある　ある

3-9 外出すると戻れない	(ない)　ときどきある　ある　テスト用架空事例
第4群 精神・行動障害	
4-1 物を盗られたなどと被害的になる	(ない)　ときどきある　ある
4-2 作話	(ない)　ときどきある　ある
4-3 泣いたり、笑ったりして感情が不安定になる	(ない)　ときどきある　ある
4-4 昼夜の逆転がある	(ない)　ときどきある　ある
4-5 しつこく同じ話をする	(ない)　ときどきある　ある
4-6 大声をだす	(ない)　ときどきある　ある
4-7 介護に抵抗する	(ない)　ときどきある　ある
4-8 「家に帰る」等と言い落ち着きがない	(ない)　ときどきある　ある
4-9 一人で外に出たがり目が離せない	(ない)　ときどきある　ある
4-10 いろいろなものを集めたり、無断でもってくる	(ない)　ときどきある　ある
4-11 物を壊したり、衣類を破いたりする	(ない)　ときどきある　ある
4-12 ひどい物忘れ	(ない)　ときどきある　ある
4-13 意味もなく独り言や独り笑いをする	(ない)　ときどきある　ある
4-14 自分勝手に行動する	(ない)　ときどきある　ある
4-15 話がまとまらず、会話にならない	(ない)　ときどきある　ある
第5群 社会生活への適応	
5-1 薬の内服	介助されていない　(一部介助)　全介助
5-2 金銭の管理	(介助されていない)　一部介助　全介助
5-3 日常の意思決定	(できる(特別な場合でもできる))　特別な場合を除いてできる　日常的に困難　できない
5-4 集団への不適応	(ない)　ときどきある　ある
5-5 買い物	介助されていない　見守り等　一部介助　(全介助)
5-6 簡単な調理	介助されていない　見守り等　一部介助　(全介助)

その他 過去14日間に受けた特別な医療

□点滴の管理　□中心静脈栄養　□透析　□ストーマ(人工肛門)の処置　□酸素療法　□レスピレーター(人工呼吸器)
□気管切開の処置　□疼痛の看護　□経管栄養　□モニター測定(血圧、心拍、酸素飽和度等)　□じょくそうの処置
□カテーテル(コンドームカテーテル、留置カテーテル、ウロストーマ等)

日常生活自立度

障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)	自立　J1　J2　A1　(A2)　B1　B2　C1　C2
認知症高齢者の日常生活自立度	自立　(Ⅰ)　Ⅱa　Ⅱb　Ⅲa　Ⅲb　Ⅳ　M

認定調査票(特記事項)

テスト用架空事例

第1群 身体機能・起居動作	体の動きは、薬が効いている時間(オン)と切れた時間(オフ)で大きく変わる。調査は午前のオンの時間に行い、ふだんの様子は妻から聞き取った。 1-3・1-4・1-8 オフの時間は動き出せず、妻が介助している。 1-5 座っていると体が前に傾くため、手で支える。 1-7 オンの時間は歩行器で歩ける。すくみ足があり、方向転換で止まる。 1-11 手のふるえがあり、妻が切っている。
第2群 生活機能	2-2 オフの時間は、トイレまでの移動に妻が手を引いている。 2-3・2-4 飲み込みに時間がかかり、ときどきむせる。妻がそばで見守っている。 2-5 夜間に2〜3回トイレに起き、妻が付き添う。ズボンの上げ下ろしを手伝う。 2-6 便秘があり、下剤の調整と後始末を妻が手伝う。 2-7 歯ブラシを細かく動かせず、仕上げみがきを妻が行う。
第3群 認知機能	3-1〜3-7 すべて答えられた。声が小さく聞き取りにくいことがある。
第4群 精神・行動障害	特記すべき行動はない。
第5群 社会生活への適応	5-1 薬は1日5回。時間がずれると動けなくなるため、妻が時間どおりに手渡している。 5-5・5-6 買い物と調理は妻が行っている。
特別な医療	該当なし。

主治医意見書

テスト用架空事例

申請者	西川 正弘 (男・74歳) 医療機関名・医師氏名:＊＊＊＊(テスト用)

1. 傷病に関する意見

(1)診断名	発症年月日
1. パーキンソン病(ホーン・ヤール重症度3度)	約8年前
(2)症状としての安定性	安定
(3)経過及び治療内容	約8年前に発症。ここ半年でウェアリング・オフ現象が強くなり、薬の効果が切れる時間(オフ)には動作が著しく困難となる。内服の回数を1日5回に調整し、症状はこの範囲で安定している。 投薬:レボドパ・カルビドパ配合剤(1日5回)、ドパミンアゴニスト、下剤。

2. 特別な医療(過去14日間以内に受けた医療)

なし

3. 心身の状態に関する意見

(1)日常生活の自立度等	障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度):A2 認知症高齢者の日常生活自立度: Ⅰ
(2)認知症の中核症状	短期記憶:問題なし/日常の意思決定:自立/意思の伝達:伝えられる
(3)認知症の行動・心理症状	なし
(4)その他の精神・神経症状	なし
(5)身体の状態	利き腕:右/身長170cm・体重58kg/筋固縮・振戦(両側)/すくみ足/姿勢反射障害/褥瘡なし

4. 生活機能とサービスに関する意見

(1)移動	屋外歩行:介助があればしている/車いす:屋外で介助者が操作することがある/歩行補助具:屋内で使用(歩行器)
(2)栄養・食生活	食事行為:見守り/栄養状態:良好/留意点:むせ込みに注意、とろみ付けを検討
(3)現在あるかまたは今後発生の可能性の高い状態とその対処方針	転倒・骨折、誤嚥性肺炎、便秘 → 服薬時間の厳守、リハビリの継続、食事の見守り
(4)サービス利用による生活機能の維持・改善の見通し	期待できる
(5)医学的管理の必要性	訪問リハビリテーション、訪問看護
(6)サービス提供時における医学的観点からの留意事項	服薬:決まった時間に確実に/移動:オフ時の転倒に注意/嚥下:むせ込みに注意
(7)感染症の有無	なし

5. 特記すべき事項

日内変動が大きく、服薬のタイミングで生活動作が大きく変わる。服薬時間を守ることと、オフの時間帯の介助が重要。